

Anamnèse

Table des matières

-1) ECOS en soi.....	1
0) Structure.....	2
1) Présentation/accueil.....	3
2) Anamnèse actuelle.....	4
3) Les caractéristiques d'un symptôme.....	4
4) Anamnèse par systèmes.....	5
5) Antécédents personnels.....	6
6 et 8) Anamnèse psychosociale combinée :	6
6) Anamnèse personnelle.....	7
7) Antécédents familiaux.....	8
8) Anamnèse psychosociale.....	8
9) Traitements.....	9
10) Clôture.....	9
11) À faire.....	10
12) À ne pas faire.....	11
13) Ce qui encadre la communication durant l'entretien (= les éléments à repérer dans les vidéos d'entretiens).....	11
14) Savoir être.....	13
15) Intimité.....	14
16) Particularités de l'anamnèse gériatrique.....	14
17) Consultation pédiatrique.....	17

-1) ECOS en soi

Cette année, c'est à fond sur la communication : appeler le patient par son nom, lui demander où il a mal, s'il est bien installé, si quelque chose le gêne, etc.

Suivre au maximum les structures données et progresser selon un ordre logique (points pour ça !)

Se laver les mains AVANT et APRÈS la sortie de la salle

Savoir caractériser les plaintes, car sort chaque année. Ne pas hésiter à creuser le côté psychosocial

Savoir faire un bilan de santé, car sort chaque année. Bien essayer de creuser le côté psychosocial et chercher une éventuelle raison cachée pour la venue du patient

Status abdominal : typiquement, le patient s'installe comme à la plage...

Toujours une analyse vidéo, où il faut souvent décortiquer se qui est bien et moins bien, tout en argumentant pourquoi. Très souvent, le problème vient de la structure avec une anamnèse qui se fait pendant le status par exemple

Très bien de finir partout par un 'J'ai examiné ce qu'il faut et je vais en parler au docteur Ruchat pour la suite' => la conclusion vaut 1 point à elle seule ! Du coup, il vaut mieux conclure précocement plutôt que de continuer à poser ses questions pointues

Électrophorèse des protéines sort quasiment chaque année, où il n'y a que la possibilité de répondre par développement

Anatomie : très souvent, on a des coupes de cerveau ou de bassin (plus précisément des photos et/ou une IRM). On demande quel truc est quoi et éventuellement quel vaisseau/nerf vascularise/innerve telle structure

Éléments à faire dans tous les postes pour les skills :

- Se laver les mains en entrant
- Se présenter et dire pourquoi on est là
- Demander l'accord du patient
- Appeler le patient par son nom et confirmer que c'est bien lui

L'ECOS est composé de 9 postes, dont :

- 2 status
- 1 anamnèse checkup
- 1 anamnèse caractérisation de plainte
- 1 poste (en 2 temps) d'analyse de vidéo
- 1 poste d'anatomie
- 1 poste d'histologie
- 1 poste biochimie

0) Structure

Définitions :

- **1) Présentation/accueil**
- 2) Anamnèse actuelle
- **3) Les caractéristiques d'un symptôme**
- 4) Anamnèse par systèmes => pas demandée en ECOS (noté cahier de module) !!
- 5) Antécédents personnels
- **6) Anamnèse personnelle**
- 7) Antécédents familiaux
- **8) Anamnèse psychosociale**
- 9) Traitements
- 10) Clôture
- 11) À faire
- 12) À ne pas faire

Remarque 1 : **les anamnèses personnelle et psychosociale se font en fait en même temps !** On les rassemble en un seul gros point à aborder en une fois ! De même, la présentation/accueil et l'anamnèse actuelle ne sont aussi qu'un seul et même point.

Remarque 2 : lorsque le patient parle de **ses maladies, traitements, ou ceux de sa famille**, toujours

s'intéresser à la **survenue** (= le facteur déclenchant) de la maladie, l'**âge** auquel elle a commencé, la **durée** de celle-ci, si elle s'est **reproduite** (si oui combien de fois, si c'était pire, etc.), s'il s'en est bien remis/le vit bien (= **évolution**) et toujours essayer de demander au patient **ce qu'il ressent** vis-à-vis de cette maladie/traitement si c'est quelque chose de grave ou qui l'affecte (ex. : infarctus du frère, traitement de chimiothérapie, etc.).

Remarque 3 : ne pas avoir peur d'empiéter sur les autres points du schéma lorsqu'on parle d'un élément (ex. : le patient nous parle du fait qu'il fume, qu'il a eu une pneumonie, que sa mère a eu une pneumonie et en est décédée => c'est le moment de faire de la prévention et de le rassurer, il ne faut pas attendre la fin !).

Remarque 4 : pour bien s'assurer du fait que le patient nous suive et n'a pas l'impression qu'on oublie de lui parler de certains éléments, faire beaucoup de métacommunication et des transitions très explicites (« Auriez-vous encore quelque chose à rajouter par rapport à ce que nous venons de discuter ? Non ? Alors, si vous êtes d'accord, nous allons maintenant passer à un sujet un peu plus intime... »).

Remarque 5 : ne pas poser de questions vagues ou où le patient ne voit pas où on veut en venir ; il faut être direct et bien lui faire comprendre ce qu'on attend comme réponse (mais sans questions suggestives ou avec des sous-entendus !).

Remarque 6 : en cas d'abus d'alcool ou de tabac, il est toujours bien de faire un peu de prévention (« Connaissez-vous les risques d'une consommation de [] ? Auriez-vous déjà pensé à arrêter ? »).

Remarque 7 : lorsqu'on pose des questions sur les maladies, les traitements, la consommation de tabac, etc., ne pas oublier de préciser leur évolution et l'âge auquel on l'a commencé.

Remarque 8 : toujours se poser la question de « Mais pourquoi vient-il me voir ? Quelle est la vraie raison de sa visite ? ». C'est pour cela qu'il est bien important d'insister au départ et à la fin de savoir s'il aimerait aborder un autre sujet en plus de ce qu'il a donné comme raison de consultation (ex. : bilan de santé juste avant de faire des voyages ? Probablement pour s'assurer que tout ira bien dans ces voyages car il en est inquiet !).

Remarque 9 : l'accueil (aussi appelé prise de contact) doit toujours comporter une question ouverte pendant laquelle il ne faut pas interrompre le patient, alors que l'étape du recueil des informations doit elle suivre une gradation avec des questions ouvertes > ciblées > fermées, mais jamais suggestives ou multiples.

Remarque 10 : des questions permettant d'aborder plusieurs points en même temps sont très utiles, comme par exemple « Est-ce que c'est la première fois que vous avez ces douleurs ? ».

Remarque 11 : éviter à tout prix de commencer à poser des questions qui n'ont aucun sens/aucun lien avec les problèmes du patient sans lui dire pourquoi on lui les pose = pourquoi est-ce qu'on commencerait à parler des repas d'une personne qui se plaint de maux de tête ? Pourquoi est-ce qu'on lui parlerait de fumée ? Il faut vraiment expliquer le rapport entre les questions et sa pathologie, sinon il n'y comprend plus rien !

Remarque 12 : ne pas hésiter à faire des silences assez longs pour permettre au patient de pouvoir réfléchir quoi répondre, ou ne pas hésiter à rappeler qu'on est sous serment médical s'il hésite à nous répondre au sujet de quelque chose de très personnel.

1) Présentation/accueil

Pour accueillir le patient, se lever, aller vers lui, lui serrer la main (et éventuellement l'inviter à s'asseoir) et se présenter en donnant son nom et sa fonction. On demande ensuite au patient si on a son accord pour que ce soit nous qui l'ausculterons (« Est-ce que vous êtes d'accord que je m'occupe

de vous aujourd'hui ? »).

Il est important de commencer par une question ouverte (la même que dans le point suivant en fait), de laisser le patient s'exprimer sans le couper et de l'écouter, lui montrer de l'intérêt. Ce point est capital, car il permet au patient d'entièrement exprimer son problème, comment il vit, souffre et se sent. On peut alors connaître la véritable raison de sa venue, autant sur le point de vue émotif que physique. Il est utile de creuser ensuite ce point, pour savoir s'il aurait des soucis particuliers, des souhaits concernant cette consultation, des attentes particulières (« De quoi aimeriez-vous qu'on parle aujourd'hui ? »). Ensuite, si c'est le cas, on peut préciser au patient qu'on a déjà reçu quelques informations sur lui et qu'on est au courant de [problèmes], rappeler le sujet et les raisons de ses éventuelles dernières visites.

Ensuite, une fois ces éléments recueillis, il est capital d'établir un agenda, en faisant beaucoup de métacommunication, en indiquant l'ordre des priorités ainsi que les différents points abordés (= quelle anamnèse), tout en intégrant tout ce que le patient vient de dire (= on ne va donc que répéter tout ce que le patient a dit et ce qui est prévu) ! Une fois cela fait, il faut lui demandeur son accord, si cela lui convient et si éventuellement il aurait vu les choses autrement (« Qu'avez-vous imaginé ce que nous puissions faire ? ») ou aurait envie de rajouter quelque chose, d'aborder un sujet supplémentaire, s'il aurait des souhaits quant à un thème particulier, si on aurait oublié quelque chose, s'il aimerait aussi parler d'un point plus émotionnel ou psychologique, etc.

Une fois tous ces points abordés, on fixe le temps dont on dispose pour couvrir tout le sujet pour éviter des malentendus.

On notera que demander le poids, la taille, l'âge et autres paramètres vitaux n'est en règle générale pas utile, tout devant normalement être noté dans le dossier du patient.

2) Anamnèse actuelle

Phrase d'accroche : « Dites-moi ce qui vous amène. ». Ensuite, il est très important de s'accorder avec le patient de ce sur quoi sera centrée toute notre anamnèse, afin d'éviter des confusions ou de passer à côté de la raison de la venue du patient.

Motif de consultation :

- 1) plainte, souffrance (patient atteint dans sa santé)
 - Si le patient évoque une douleur par un terme spécial (« J'ai une crise de foie »), essayer de d'abord comprendre ce qu'il entend par ce terme, qui est souvent différent de sa signification réelle
- **2) bilan de santé (patient peut être en bonne santé)**
 - **(On y retrouve surtout le bilan psychosocial !)**

3) Les caractéristiques d'un symptôme

On ne le fait pas dans le cas d'un bilan de santé !

« Parlez-moi un peu plus de cette douleur. »

- 1) Localisation et irradiation

- L'irradiation est une question importante qui doit être en accord avec la douleur, c'est-à-dire qu'il faut la relier à un symptôme possible causé par cette douleur. Il ne suffit pas de demander « Est-ce que la douleur se diffuse autour de ce point ? », mais il faut proposer des chemins qu'elle pourrait prendre (« Est-ce qu'elle vous va jusque dans le bras ? Est-ce qu'elle se projette jusque dans le côté gauche de votre ventre ? »). Ne pas hésiter à montrer avec les mains en accompagnant la parole et à demander au patient de localiser l'épicentre de la douleur, ainsi que son irradiation avec des gestes.
- 2) Qualité (serrement, colique, brûlure, décharge électrique, piquûre, coup de poignard, déchirement, etc.)
- 3) Intensité (échelle de 0 à 10)
 - Exemplifier l'échelle ou au moins dire « 0 étant une absence de douleur et 10 une douleur insoutenable/la pire douleur qui soit ». Il est aussi important de se renseigner si la douleur évolue avec le temps, par exemple si elle augmente avec le temps (= va en crescendo) ou si elle reste identique, se calme avec le temps, etc.
 - La douleur est aussi un point important où demander comment le patient se sent vis-à-vis d'elle et comment il vit cette douleur !
- 4) Chronologie (début, fin, durée, fréquence)
- 5) Condition de survenue
 - Essayer d'approfondir les conditions de survenue, pour savoir si la douleur apparaît avec un effort (si oui quel genre), si elle apparaît au repos, dans une certaine position, avec le froid, quand on avale, avec certains mouvements, après manger, etc. Demander si la douleur apparaît aussi lorsqu'on presse sur le point douloureux ou non, pendant la respiration, etc.
- 6) Facteurs le modifiant (aggravant ou soulageant)
- 7) Manifestations associées = autres douleurs/éléments liés au problème
 - Par exemple, de l'asthme et de la toux, des 'fausses routes' et des brûlures d'estomac, de la sueur avec une douleur intense, des nausées avec des étourdissements, etc.

À la fin toujours faire une synthèse, entre autre pour montrer qu'on a écouté le patient et compris son problème, mais surtout pour s'assurer (et recevoir sa confirmation) qu'il n'a pas fait d'erreur dans l'énonciation de son problème sur n'importe lequel des points.

Demander au patient si, éventuellement, il n'aurait pas remarqué quelque chose de bizarre ou de paradoxal concernant ces douleurs et d'éventuels symptômes associés (une perte de poids associée à ses douleurs de ventre, mais un sentiment de ballonnement par exemple).

4) Anamnèse par systèmes

NE SORTIRA PAS À L'ECOS, ON AURA JAMAIS LE TEMPS ET ON NE CONNAÎT PAS LES BASES DES MALADIES !

5) Antécédents personnels

- Les maladies et leurs traitements
 - Dans les maladies, ne surtout pas oublier de maladies chroniques/qui récidiveraient souvent, et donner un exemple/bien expliquer ce qu'on entend par ces deux types de maladies.
- Les accidents et les blessures
- Les opérations
- Les hospitalisations

6 et 8) Anamnèse psychosociale combinée :

- État général ressenti par le patient (physique et mental)
- La situation à domicile
 - Demander où la personne vit (et si dans un immeuble à quel étage et si cet immeuble comporte un ascenseur), avec qui et ses conditions de vie.
- La situation conjugale
 - Demander si la personne est mariée ou est avec quelqu'un et éventuellement se renseigner si tout va bien dans cette relation. Se renseigner sur d'éventuels divorces et s'ils ont eu un effet sur le moral ou la manière de vie de la personne. Se renseigner sur quelque chose que son conjoint aurait remarqué de bizarre/lui aurait fait remarquer/lui aurait souvent répété.
- Les enfants
 - Se renseigner sur leur âge (adolescents => peuvent être difficiles à vivre), la relations parent-enfant et inversement, leur départ de la maison (qui pourrait rendre les parents tristes, inquiets, etc.), un éventuel décès dur à supporter, etc. Par extension, se renseigner sur d'éventuelles mauvaises relations familiales, des événements familiaux durs à supporter (décès d'un proche, annonce d'un cancer, etc.).
- (La vie au quotidien) (sauf si intéressant)
 - Description d'une journée typique (ou en tout cas de phases qui pourraient être intéressantes), de son rythme de vie et d'activités spéciales dans la semaine.
- (Habitudes alimentaires) (sauf si intéressant)
- Mode de vie
 - Est-il végétarien ? Sportif ? Gamer accro ? Apathique ? Etc.
- Emploi
 - Demander ce qu'il en est des horaires, des charges, du stress, de la qualité de son environnement, d'éventuels longs trajets, etc.
- Les vaccinations
 - « Est-ce que votre carnet de vaccinations est à jour ? »
- Voyages

- Exercices et loisirs
- Allergies
- Alcool, tabac et stupéfiants
 - Dans ce cas là, toujours demander la quantité de produit consommée par jour (= si le patient dit « Un peu », ça veut dire combien précisément ?) et depuis combien de temps. On peut aussi utiliser le système UPA avec le tabac, c'est-à-dire qu'on demande au patient combien de paquets il consomme par jour et depuis combien de temps il a commencé à consommer => 10 UPA = 1 paquet/jour pendant 10 ans.
- Risques liés à l'environnement = est-ce que quelque chose dans l'environnement de vie de la personne pourrait expliquer son problème
- (Vie sexuelle) (à bien amener et n'en parler que si la situation semble propice (ex. : vieux de 60 ans, divorcé, qui part seul au Vietnam... Suspect non ?)
- Les opinions du patient
 - Très important dans la médecine actuelle ou l'avis du patient compte. De plus, s'il a lui-même l'occasion de s'essayer à poser son diagnostic ou encore à trouver des corrélations, il n'en sera que plus heureux et satisfait (ou en tout cas intrigué). Ce point peut aussi livrer de nouvelles informations sur des relations inattendues que le patient aurait lui-même faites et à côté desquelles on serait passé (« Avez-vous une explication vous-même ? Qu'est-ce que vous imaginez comme cause pour [] ? »).
- Relier des activités à son problème
 - S'il a eu de l'asthme dans son enfance et que, soudain, en allant faire les foins, il a de la peine à respirer, mais qu'il pensait que ça pourrait venir du fait de l'exercice et non de faire les foins !

6) Anamnèse personnelle

Phrase d'accroche : « J'aimerais à présent aborder avec vous des sujets un peu plus personnels... ».

- État général ressenti par le patient (physique et mental)
- Les vaccinations
 - « Est-ce que votre carnet de vaccinations est à jour ? »
- Voyages
- Emploi (revient dans l'anamnèse psychosociale)
 - Demander ce qu'il en est des horaires, des charges, du stress, de la qualité de son environnement, d'éventuels longs trajets, etc.
- (Habitudes alimentaires) (sauf si intéressant)
- Exercices et loisirs (revient dans l'anamnèse psychosociale)
- Allergies

- Alcool, tabac et stupéfiants
 - Dans ce cas là, toujours demander la quantité de produit consommée par jour (= si le patient dit « Un peu », ça veut dire combien précisément ?) et depuis combien de temps. On peut aussi utiliser le système UPA avec le tabac, c'est-à-dire qu'on demande au patient combien de paquets il consomme par jour et depuis combien de temps il a commencé à consommer => 10 UPA = 1 paquet/jour pendant 10 ans.
- Risques liés à l'environnement = est-ce que quelque chose dans l'environnement de vie de la personne pourrait expliquer son problème
- (Vie sexuelle) (à bien amener et n'en parler que si la situation semble propice (ex. : vieux de 60 ans, divorcé, qui part au Vietnam... Suspect non ?)

7) Antécédents familiaux

- (Pathologies retrouvées dans la famille) => trop vague, à bannir, car le patient ne sait pas où on veut en venir. Il faut bien l'aiguiller et poser des questions sans équivoque.
- Pathologies (et causes de décès) des parents et grands-parents
 - Attention au fait de parler de ses beaux-parents ! Ils ne font pas partie de la famille, mais ça peut être un piège !
- Pathologies chez les frères et sœurs
- Pathologies chez les enfants

8) Anamnèse psychosociale

Capitale dans le bilan santé. Il est aussi nécessaire de voir et de demander comment le patient vit sa maladie/son problème à travers les points énoncés ci-dessous, s'il se sent affecté, comment il le vit, etc. Les répercussions et l'impact de chacun de ces points sur sa vie sont la clé de ce point (par exemple de savoir si [] le gêne).

- La situation à domicile
 - Demander où la personne vit (et si dans un immeuble à quel étage et si cet immeuble comporte un ascenseur), avec qui et ses conditions de vie.
- La situation conjugale
 - Demander si la personne est mariée ou est avec quelqu'un et éventuellement se renseigner si tout va bien dans cette relation. Se renseigner sur d'éventuels divorces et s'ils ont eu un effet sur le moral ou la manière de vie de la personne. Se renseigner sur quelque chose que son conjoint aurait remarqué de bizarre/lui aurait fait remarquer/lui aurait souvent répété.
- (La vie au quotidien) (sauf si intéressant)
 - Description d'une journée typique (ou en tout cas de phases qui pourraient être intéressantes), de son rythme de vie et d'activités spéciales dans la semaine.
- Mode de vie

- Est-il végétarien ? Sportif ? Gamer accro ? Apathique ? Etc.
- Les enfants
 - Se renseigner sur leur âge (adolescents => peuvent être difficiles à vivre), la relations parent-enfant et inversement, leur départ de la maison (qui pourrait rendre les parents tristes, inquiets, etc.), un éventuel décès dur à supporter, etc. Par extension, se renseigner sur d'éventuelles mauvaises relations familiales, des évènements familiaux durs à supporter (décès d'un proche, annonce d'un cancer, etc.).
- Emploi
 - Demander ce qu'il en est des horaires, des charges, du stress, de la qualité de son environnement, d'éventuels longs trajets, etc.
- Loisirs
 - Exercices ou sport particulier ? À risque ?
- Les opinions du patient
 - Très important dans la médecine actuelle ou l'avis du patient compte. De plus, s'il a lui-même l'occasion de s'essayer à poser son diagnostic ou encore à trouver des corrélations, il n'en sera que plus heureux et satisfait (ou en tout cas intrigué). Ce point peut aussi livrer de nouvelles informations sur des relations inattendues que le patient aurait lui-même faites et à côté desquelles on serait passé (« Avez-vous une explication vous-même ? Qu'est-ce que vous imaginez comme cause pour [] ? »).
- Relier des activités à son problème
 - S'il a eu de l'asthme dans son enfance et que, soudain, en allant faire les foins, il a de la peine à respirer, mais qu'il pensait que ça pourrait venir du faire de l'exercice et non de faire les foins !
- (Les expériences importantes)
- (Les croyances religieuses)

9) Traitements

- Le traitement régulier
- Les traitements occasionnels
- Les « substances annexes » (vitamines, plantes, etc.)
 - Il est utile de nommer les différentes possibilités, les patients n'y pensant pas forcément eux-mêmes ou ne comprenant pas la question (toujours éviter d'être vague !).

10) Clôture

Résumer les points importants avec le patient et s'assurer de n'avoir raté aucune information capitale et assurer qu'on a bien compris son problème et qu'on va y donner suite (« J'ai tout à fait compris vos inquiétudes/vos douleurs/votre ressenti vis-à-vis de votre maladie et je me chargerai d'assurer de la transmission de tout le contenu de notre entrevue d'aujourd'hui au Dr ... ». Il faut aussi

s'assurer que le patient a bien tout compris si des traitements sont donnés et **surtout** ne pas oublier de lui demander avant de partir s'il n'aurait pas oublié de parler de quelque chose qui le gênerait ou s'il aurait oublié un détail, ou encore s'il aimerait parler d'un autre problème qui lui pèse. Finalement, lui affirmer qu'on reste entièrement à sa disposition s'il a un doute, un problème, une douleur, etc. et qu'il aimerait venir nous en parler.

11) À faire

- Adopter une posture ouverte
- **Penser que toutes les informations sont importantes et essayer de faire des liens avec son problème = essayer de suivre le maximum des pistes/perches tendues par le patient**
- **Toujours garder le côté social/humain = comment il le sent/le vit ?**
- Avoir une attitude engagée, enthousiaste et intéressée dès le début
- Avoir un vrai dialogue avec le patient et non un sermon où on lui balance des tonnes d'informations et on l'assaille de questions sans qu'il ne puisse faire quoi que ce soit
- Parler lentement, calmement, posément, avec assurance
- Transitions explicites
- Métacommunication
- Résumés intermédiaires réguliers
- Le reprendre, reformuler, clarifier certaines informations qui seraient confuses. Aussi important pour ce qu'il montre non verbalement (pleure, rougit, etc.)
- Avoir un cadre adéquat (nous sommes son confident, à qui il peut révéler des choses lourdes ou très gênantes, donc il faut impérativement protéger son intimité et lui garantir un climat de confiance et de respect mutuel !)
- Avoir une structure
- Écouter et légitimer ce que vit le patient (dans la mesure du raisonnable), le soutenir (« Nous allons voir ce qu'on peut faire. »), respecter ses efforts de cacher ses émotions
- Adapter le langage et éviter le jargon = vulgariser, paraphraser
- Interrompre avec tact (« Je m'excuse, mais nous nous éloignons de la question initiale et je me permet de vous recentrer. Seriez-vous d'accord que nous reprenions la question par le début ? Je vous rappelle : je vous avais demandé si... »)
- Lui demander des faire des liens = « Pensez-vous que [problème] pourrait être lié à [élément dit] ? »)
- En cas de blanc ou de trou, plutôt que de rester la bouche bée en mode poisson mort devant le patient et lui faire sentir son haleine perfide et putride de sandwich au thon, dire explicitement « J'aurais besoin de quelques secondes pour réfléchir. Me les accordez-vous ? »)
- Il peut être utile de préciser, lorsqu'on aborde des questions délicates ou très personnelles, de rappeler qu'il nous est interdit de répéter quoi que ce soit de ce que le patient va nous dire, qu'il ne doit en aucun cas en avoir honte, etc.

12) À ne pas faire

- Dire « Très bien », « Parfait », « Excellent » ou autre lorsque la personne annonce quelque chose de grave, comme « Mon frère a subi un infarctus l'année dernière... »
- Adopter une posture fermée (bras/jambe croisées)
- Poser des questions suggestives (= avoir un diagnostic en tête et demander « Vous n'auriez pas mal à la tête ? Au bras gauche ? Etc.) ou encore multiples (= lui demander pleins d'informations en une fois)
- Utiliser du jargon
- Couper la parole parce qu'il va trop loin, mais sans tact
- Ne pas lui laisser le temps de s'exprimer
- Le consoler précocement
- Juger (« Cela n'est pas grave... Cela c'est vraiment bien... »)
 - Pour éviter de juger, si par exemple, il consomme beaucoup trop de tabac, demander si « Connaissez-vous les risques d'une consommation élevée de tabac ? Auriez-vous pensé à arrêter d'en consommer ? »

13) Ce qui encadre la communication durant l'entretien (= les éléments à repérer dans les vidéos d'entretiens)

1. Le contexte de l'entretien

Il est essentiellement déterminé par le lieu où se fait la consulte, donnant un cadre (agréable ou non ; il peut également aider à structurer l'entretien) qui doit être calme, donner l'impression de l'écoute du patient et respecter son intimité. Il doit aussi si possible donner une l'impression au patient que lui-même et le médecin sont à un niveau semblable (= il ne doit pas accentuer cette différence, par les meubles, les diplômes, le discours, etc.).

2. La dimension temporelle

Elle est surtout conditionnée par la durée de l'entretien, mais aussi par le temps d'attente avant la consulte (plus il est long, plus il augmente l'anxiété, l'hostilité et la dépendance vis-à-vis du médecin) => toujours bien de s'excuser si on a un retard pour se montrer empathique face au patient qui a longtemps attendu.

3. Le climat émotionnel et les aspects non-verbaux

Il est important de respecter la distance physique, qui doit être personnelle (entre 1m et 1,5m) et non pas sociale (3m). Il faut de plus faire attention à la posture (ouvert/fermé (attention au fait qu'une posture avec les jambes croisées de la part du médecin ou du patient peut aussi montrer de l'intérêt !), nerveux quand on triture un stylo, on touche périodiquement son visage, ou quand on tourne sur sa chaise, etc.).

Mais pourquoi ces éléments sont-ils importants pour le patient ?

- 90% des patients accordent de l'importance à la qualité des informations données, ainsi que 80% au soutien émotionnel apporté ; en comparaison, la qualité des soins médicaux est importante pour 85% des patients !

- Le manque d'informations est le principal problème rencontré par les patients, se retrouvant dans 30% des consultations
- L'anamnèse peut expliquer à elle seule le problème du patient dans 20% des cas, alors qu'une anamnèse suivie d'un simple examen physique peut expliquer le problème du patient dans 40% des cas => dans environ 60% des cas, une anamnèse et un examen physique simple suffisent à poser le diagnostic !
- Environ 80% de l'information totale fournie par l'entretien provient de l'anamnèse, alors que 15% proviennent de l'examen physique et les 5% restants proviennent eux des examens paracliniques
- Cependant, on notera que, pour les patients, un examen clinique est souvent une attente importante, le fait de toucher/palper/rechercher le problème du patient sur son corps lui confirmant qu'il a un problème et que le médecin le recherche activement

Les nombreuses difficultés dans la communication provoquent une discordance sur le motif principal de la consultation dans ~ 50% des cas (induisant la cause majeure (70%) des problèmes médico-légaux), les problèmes majeurs étant (1) le fait que le médecin coupe le patient avant qu'il ait eu le temps d'exposer pleinement sa plainte et (2) que le médecin ne suit que 20% des pistes données par le patient.

Un bon entretien doit ainsi incorporer à la fois des éléments bio-médicaux (= les symptômes, la structure académique de l'anamnèse, etc.), la perspective du patient (= ses émotions, les répercussions sur sa vie, etc.) et le contexte dans lequel ce problème se place chez le patient (= antécédents, famille, profession, etc.).

Tous ces éléments permettent de construire une bonne relation entre le patient et son médecin, permettant au patient de se sentir écouté et soutenu, améliore l'efficacité de l'entretien, favorise une relation sur la durée, favorise le rôle actif du patient et finalement permet de prévenir les conflits.

Ainsi, la communication et la relation avec le patient peuvent être résumés dans le modèle des « 4 E » :

- Engagement
- Empathie
- Éducation
- Enrôlement (= être le partenaire du patient pour favoriser son adhésion au plan du médecin)

Pour tout le domaine des émotions, il faut toujours se montrer empathique, c'est-à-dire de laisser du temps, éviter les consolations précoces (= recueillir les informations et les émotions du patient, les construire et les développer avec lui pour bien le comprendre, puis finalement légitimer le tout, mais seulement une fois la situation globale cernée) et finalement ne surtout pas quitter ce thème délicat sans une transition explicite. Si le médecin se montre justement non-réceptif, il risque de trop se focaliser sur les aspects médicaux et pas suffisamment sur les aspects personnels du patient, de renvoyer une image de non-disponibilité et de consoler précocement (« Ne vous en faites pas, tout va s'arranger »).

14) Savoir être

Il faut premièrement discuter d'un « grand problème » de la médecine : la relation médecin-patient. Souvent, elle se réalise bien, mais parfois on peut retrouver des malentendus qui peuvent être blessants tant pour les patients que pour les médecins. Pour en parler, les patients utilisent plutôt le champ lexical de la boucherie, alors que les médecins se comparent eux à des animaux, maltraités par les patients en colère.

L'un des problèmes de cette relation est le fait que, suivant les patients (surtout pour les cas les plus complexes), c'est tout un groupe de médecins qui le prennent en charge, et non pas une seule personne. Du coup, les patients voient (à juste titre) que personne n'est vraiment responsable d'eux, cette responsabilité étant diluée entre tous les intervenants.

Souvent, ce sont les conditions émotionnelles qui sont le plus à risque de provoquer des tensions. En effet, les patients (ou leur famille), pris en charge par plusieurs personnes différentes (= pas de vision unique), ne se sentent pas écoutés et compris, car les dossiers passant de mains en mains ne concernent que les informations médicales et non émotionnelles du patient. Du coup, alors qu'ils pensent avoir des idées sur ce qui leur arrive et aimeraient les partager avec le médecin, ils ne se font pas écouter (= médecins trop fermés) et développent de la rancœur pour ces médecins. Souvent, ils explosent quand un déclencheur (facture trop salée, mauvais traitement, etc.) se fait sentir, et là commencent à critiquer les médecins.

Un autre aspect de cette relation se rencontre aussi dans les urgences : un médecin assistant navigue entre tous les cas, mais a très peu de pouvoir : ceci explique qu'il n'arrive pas à répondre aux questions de tous les patients, car il ne peut pas (par manque de temps ou de pouvoir) ou ne sait pas répondre. Ces médecins décident du coup souvent d'esquiver les réponses (au lieu de dire « Il faut que je demande au médecin-chef »), ce qui énerve les patients, qui veulent alors parler au chef de clinique, celui qui sait.

Un autre problème rencontré pendant la relation patient-médecin est le fait que les patients ont souvent peur de dire que quelque chose ne va pas directement au médecin concerné et préfèrent se tourner vers des tiers pour le faire « dans leur dos ». En effet, s'ils critiquent le médecin, ils ont peur de subir des représailles et de se faire mal voir, les forçant à se taire ou à en parler à quelqu'un d'autre.

Dans le cas de la pédiatrie, où les parents sont intégrés le plus possible, des tensions peuvent aussi apparaître, les parents étant sûrs de savoir de quoi souffre leur enfant, alors que le médecin pas forcément.

Une critique revenant souvent contre les médecins est leur manque de connaissance, mais surtout d'ouverture, dans le domaine des médecines alternatives.

En conclusion, on a donc surtout que même si plusieurs soignants différents s'occupent d'un même patient, il ne faut pas attendre que les conflits enflent jusqu'à exploser, en se disant « De toute façon c'est le suivant qui va s'en occuper », mais immédiatement reconnaître un conflit (ce qui peut être très difficile pour un soignant, car il doit se remettre en question ; de plus, il ne faut jamais ignorer un conflit, sinon il empire) et chercher à le désamorcer tout en réparant le problème autour duquel il tourne. Il faut aussi bien remarquer que les patients souffrent de ces conflits, mais les médecins eux-aussi ! Souvent, la source de ces conflits est le manque d'informations données par les médecins dans des moments riches en émotions, surtout autour du tabou de la mort, où personne n'ose en parler, croyant que l'autre (le médecin ou le patient, suivant le point de vue) ne fait que gêner la guérison du patient, alors que nous-même savons quoi faire.

Un dernier point à noter : souvent, les médecins définissent les poseurs de doléances (= les patients mécontents) selon leur état émotionnel (furieux, révolté, etc.), leur manière d'être au monde (éternel insatisfait, etc.), leur attitude (méfiant, menteur, etc.) et leur traits de personnalités (africain,

émotivité marocaine, etc.) de manière négative, rejetant presque toujours la faute sur le patient, alors que la bonne méthode serait plutôt de se remettre en question soi-même et voir « Où j'ai fait une faute » et non « C'est le patient qui est comme ça » !

Le savoir être : premièrement, on peut le voir comme un reflet de l'éducation et d'un bon comportement (être souriant, ponctuel, serviable, etc.). Cependant, il est plus que cela : on peut le voir en plus comme une autonomie personnelle, un sens critique envers soi (et ne pas rejeter systématiquement la faute sur les patients !), ainsi qu'une prise de conscience de ses responsabilités.

En médecine, on voit souvent le soin comme un même contenu qu'on donne à chaque patient, la manière de le donner n'important pas. En effet, on pense qu'ajouter des émotions à un traitement relève du surjoué, de la manipulation, voire même de la malhonnêteté, donc quelque chose de superflu, voire même quelque chose à éviter. De plus, comme les médecins jouissent d'une certaine image (de part leur statut de « professionnels », qui leur octroie des privilèges, une autonomie, un bon revenu, etc.) de personnes sérieuses, efficaces et peu émotives, briser cette image par des émotions est à éviter.

On retrouve plusieurs obstacles au savoir-être en médecine :

- Les inégalités sociales entre les patients, alors qu'un médecin se devrait de tous les traiter de manière égale
- La collusion d'anonymat : tellement de personnes différentes s'occupent d'un seul patient que personne n'en est en fait responsable
- Pacte dénégatif : 2 équipes dans la médecine (les patients et les soignants), qui sont de vrais camps qui sont l'un contre l'autre et totalement différents l'un de l'autre. Par exemple, un soignant ne peut pas s'identifier au patient, ne peut pas tomber malade, ne doit pas avoir d'émotions, etc.
- L'angoisse : touche surtout la mort, qui est un tabou dont on ne doit pas parler (le conflit pourrait même être une échappatoire pour ne justement pas parler de la mort !)
- D'autres sentiments forts comme la colère, la déception, etc.

Pour savoir être, il faut donc être honnête et en avoir le courage, mais aussi pouvoir s'adapter au patient et à ses besoins (et non l'inverse) tout en restant soi et en répondant à sa façon (dans le cadre de soins rationnels évidemment).

15) Intimité

Le patient n'a pas le choix de l'examen qu'il doit effectuer et peut difficilement choisir s'il est fait par une personne du même sexe ou non. Du coup, il peut y avoir un sentiment de malaise.

Les deux facteurs principaux conditionnant la gêne d'un patient sont son âge et sa religion.

Un bon moyen de ne pas choquer le patient pendant les examens est de surtout expliquer ce qu'on va faire et comment, pour éviter tout malentendu. En effet, comme le toucher touche à la sphère intime du patient, il faut exprimer du respect, du tact et de la pudeur envers lui, et aussi parce que le toucher est une partie très importante du langage entre le médecin et le patient.

16) Particularités de l'anamnèse gériatrique

Éviter les préjugés (surtout négatifs) à leur égards, considérer que leur anamnèse permet tout à fait de comprendre leur problème et qu'on les retrouve majoritairement dans les hôpitaux de soins aigus.

Dans les points importants de l'anamnèse des personnes âgées, il faut souligner l'importance d'une approche globale, touchant bien plus de domaines que le pur médical. Il faut ainsi intégrer une approche fonctionnelle : se poser la question de la *pathologie* (ex. : TA trop élevée), qui peut entraîner une *déficience* touchant un organe ou un système (ex. : insuffisance cardiaque), provoquant une *limitation fonctionnelle* (une incapacité physique ou mentale¹ ; ex. : incapacité à monter les escaliers, ce qui bloque la personne chez elle) qui finalement va aboutir à une *limitation de rôle* (dans la société, par un handicap ; ex. : placement).

Ceci amène à un aspect qui se rajoute à l'anamnèse sociale : l'anamnèse fonctionnelle. Elle va permettre d'explorer les paramètres physiques, affectifs, cognitifs, la mobilité, l'environnement socio-économique, etc. de la personne âgée, chacun de ces éléments (parfois très éloignés du domaine médical !) influençant sa qualité de vie. De plus, ces différents critères sont aussi utilisés pour déterminer si une personne âgée doit être placée ou non.

Pour l'évaluer, on peut par exemple utiliser un système de points pour déterminer les capacités de la personne à réaliser des activités dites « de bases » ou « instrumentales » (les deux sont évaluées de manière binaire (0 ou 1), explorant si la personne arrive à se débrouiller seule, avec une faible assistance ou si elle est totalement dépendante) : les activités de base sont les activités quotidiennes nécessaires au fonctionnement de base de la personne :

- 1) Se baigner
- 2) S'habiller
- 3) Aller aux toilettes
- 4) Se transférer (= se déplacer)
- 5) Continence
- 6) Se nourrir

Les activités instrumentales (ou Activités Instrumentales de la Vie Quotidienne AIVQ) sont quant à elles des activités qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de base de la personne.

- 1) Utilisation du téléphone
- 2) Commissions
- 3) Préparation des repas
- 4) Ménage
- 5) Lessive
- 6) Transports
- 7) Médicaments
- 8) Finances

Ces différentes échelles et leur système de point sont utiles pour déterminer l'indépendance de la personne, mais sont également un bon facteur pronostique pour savoir si la personne va bientôt développer une maladie dégénérative ou éventuellement décéder.

Dans les problèmes majeurs qui rendent difficile l'évaluation de personnes âgées par une anamnèse, on a :

¹ (Souvent, on privilégie la qualité de vie plutôt que la durée pour les personnes âgées)

- La communication
 - Mauvaise audition : faire les examens dans une pièce calme, bien articuler en parlant fort ($\neq$ crier), s'assurer que la personne possède son appareil auditif, éventuellement rechercher des bouchons de cire, etc.
 - Mauvaise vision : ne pas se mettre à contre-jour, lui faire porter ses lunettes, etc.
 - Ralentissement psycho-moteur : se donner le temps, leur laisser le temps de se concentrer et de répondre (comme ils répondent lentement (âge avancé) et ont de multiples problèmes de santé, ils sont très à risque d'être coupés pendant qu'ils parlent de leur problème principal !), éventuellement fragmenter l'anamnèse, etc.
 - Banalisation des symptômes : les patients ainsi que les médecins peuvent banaliser le fait, qu'avec l'âge, il devient naturel (ce qui n'est pas le cas) de chuter, d'avoir des incontinences, d'avoir une moins bonne mémoire ou de sentir seul et triste. Du coup, les patients n'en parlent pas et les médecins ne le demandent pas ! De plus, comme il n'existe pas de remède contre ces différents problèmes, les médecins n'en parlent pas, « parce que de toute façon on ne peut rien faire ! ».
- Cette banalisation est ainsi un réel problème, faisant en sorte que moins de 30% des personnes atteintes des différents problèmes mentionnés ne sont pas diagnostiquées ! Typiquement, la prévalence de la démence, largement sous-estimée, est de 2% à 65 ans, puis double tous les 5 ans !
- La solution est donc de poser systématiquement des questions touchant ces problèmes gériatriques, de manière la plus spécifique possible, tout en essayant au maximum de reformuler les questions gênantes (ex. : incontinence) pour limiter leur inconfort.
- Troubles cognitifs, mémoire (peuvent être banalisés !) : rechercher d'autres sources, par exemple par l'hétéro-anamnèse.

L'hétéro-anamnèse est une forme d'anamnèse pour un patient, mais qui est faite auprès d'un tiers (proches ou professionnels), qui permet de compléter (mais ne remplace pas !) l'anamnèse gériatrique. Elle se révèle être très utile pour les personnes atteintes de troubles cognitifs, mais attention : à moins d'une urgence, il faut légalement demander si la personne concernée y consent ! De plus, une personne dont la mémoire est totalement défaillante ne pourra peut-être pas se souvenir d'événements récents, mais sera à même de décrire comment elle se sent immédiatement => toujours faire l'anamnèse gériatrique, quoi qu'il arrive !

Si une personne âgée se fait accompagner lors d'une de ses visites (= hétéro-anamnèse), toujours lui demander si elle souhaite que son accompagnant reste durant les examens et toujours trouver un moment pour discuter avec la personne âgée sans cet accompagnant (personnes âgées souvent victimes de maltraitance !).

On peut aussi retrouver des problèmes dans l'interprétation de l'anamnèse des personnes âgées :

- Symptômes vagues et/ou présentation atypique de leurs maladies
- Plaintes multiples (elles souffrent souvent de plusieurs maladies chroniques)
- Polypathologie : le fait qu'un seul symptôme peut être la conséquence d'un problème dans des systèmes totalement différents

Au final, on a donc que l'anamnèse gériatrique doit donc surtout se concentrer sur les anamnèses sociale, fonctionnelle (une partie en plus de l'anamnèse « classique ») et sur les habitudes et traitements des patients. De plus, dans l'anamnèse par systèmes, il faudra surtout s'intéresser aux problèmes typiquement gériatriques, qui sont souvent banalisés et oubliés.

17) Consultation pédiatrique

Tout d'abord, les enfants ont plusieurs droits : de survie (= nourriture, abri, etc.), de développement (= éducation, religion, etc.), de protection (= contre l'abus, l'exploitation, etc.) et de participation (= pour les décisions qui le concernent et celle de sa communauté). De plus, on considère la pédiatrie comme la médecine qui s'occupe des enfants (dont il existe plusieurs sous-classes) jusqu'à la fin de la croissance et de leur développement, ce qui correspond jusqu'à la majorité civile en Suisse.

Dans le monde, 95% des décès chez les enfants se retrouvent dans les pays peu développés (principalement l'Afrique et l'Inde), et 30% de ces décès sont attribués à la malnutrition (et dans les pays riches à l'obésité, avec une prévalence de 1 enfant sur 4 !). De plus, la couverture des interventions (= le nombre de cas ayant bénéficié d'une telle intervention) est et reste très faible, depuis la contraception en passant par l'accouchement et les vaccins.

Dans les pays développés, les problèmes les plus récurrents sont les maladies chroniques (obésité, oncologie, maladies rares, etc.), les maladies psycho-sociales/comportementales (jusqu'à 30% des enfants sont pris en charge pour ce genre de problèmes !) et les handicaps.

Pour prendre en charge des enfants, on doit appliquer la PECIME (= Prise En Charge Intégrée des Maladies de l'Enfance), qui se base plus généralement sur 3 objectifs :

- 1) Améliorer les compétences des agents de santé (grâce à des directives adaptées aux circonstances locales)
- 2) L'amélioration des pratiques familiales et communautaires (= éduquer les parents du malade)
- 3) Renforcer les soutiens au système de santé (= avoir un système efficace et qui marche, qui a une structure adéquate et adaptée)

La PECIME est aussi une approche très globale de l'enfant en lui-même, qui ne vise pas qu'à le soigner et s'en aller, mais aussi d'explorer sa croissance, son alimentation, ses vaccins, son développement, ses relations avec son entourage, son épanouissement, etc., ces paramètres étant les causes de consultations principales pour les enfants (où il est capital de rassurer les parents de la normalité de la situation et de les encourager, ou alors de les remettre dans le droit chemin s'il le faut) ! De ce fait, c'est une approche qui se veut très 'communautaire', c'est-à-dire qu'elle va chercher à toucher l'enfant mais aussi toute sa famille (modèle systémique, où la famille toute entière est un acteur important).

Pendant toute la prise en charge, il faut appliquer les mêmes principes éthiques que pour l'adulte, à savoir : la bienfaisance, le respect de la personne (= autonomie) et la justice sociale (= équité). De plus, tout comme l'anamnèse pour adulte, il est indispensable de :

- Écouter les parents ET l'enfant (dans l'idéal s'adresser d'abord à l'enfant)
- Expliquer la tournure des événements
- Laisser les parents et l'enfant s'expliquer SANS LES COUPER

- Principalement parler avec et observer l'enfant pour déterminer le problème et non pas tout de suite tester (p. ex. : sortir le stéthoscope sans poser de question)
- Établir un climat de confiance et l'alliance thérapeutique
- Accueillir et quitter comme il se doit
- Être empathique
- Adapter le langage
- Être très attentif au langage non-verbal de l'enfants
- Les examens, quels qu'ils soient (surtout les para-cliniques), doivent toujours être faits après l'anamnèse
- Toujours faire des synthèses intermédiaire et finale, surtout en disant aux parents de quoi il s'agit, s'ils auraient pu l'éviter, si c'est susceptible de se reproduire, l'évolution attendue et le traitement (l'enfant voudra plutôt lui savoir quand il pourra rentrer à la maison)

[Pour les adolescents, on tombe souvent sur un 'agenda caché', où ils viennent sans cesse pour consulter pour un problème, mais en fait la vraie raison de leur consultation est tout autre. Ainsi, il faut appliquer le HEADSSS :

- Home
- Education/Eating
- Ativities
- Drugs (légaux ou non)
- Sexuality
- Suicide
- Violence

]

La démarche PECIME :

- 1) Motif de consultation
- 2) Tri grâce aux signes de danger et prioritaires
 - Appliquer le 'Triangle d'Évaluation Pédiatrique' ou TEP, c'est-à-dire explorer les aspects généraux (tonus musculaire et conscience), la respiration (position, travail et bruits respiratoires) et l'hémodynamique (couleur de peau et chaleur), sans utiliser un quelconque appareil mais simplement en un coup d'oeil.
 - À noter : la situation des enfants, surtout les plus jeunes, peut très vite évoluer => il faut les réévaluer !
- 3) Symptômes principaux
 - Toux
 - Fièvre

- Diarrhée – vomissement
- ORL
- 4) Status nutritionnel
 - Il faut toujours mesurer un enfant, que ce soit son poids, sa taille ou son périmètre crânien (plutôt jusqu'à ~ 1 an) pour évaluer la croissance (qui est plutôt axée sur l'alimentation en début de vie et les hormones à l'adolescence) des enfants et sa vitesse, qu'on comparera aux courbes de croissance.
- 5) Status vaccinal
 - Permet d'exclure ou de soupçonner les nombreuses maladies (pas comme le tétanos) contre lesquelles on peut vacciner les enfants.
- 6) Développement psycho-moteur
 - Il est divisé en 4 domaines : les motricités fine et grossière, la sociabilité (et les émotions) et finalement la communication (audition et langage = est-ce qu'il comprend ce qu'on lui dit et est-ce qu'il arrive à répondre). Cet examen est relativement complexe, les enfants évoluant chacun à leur rythme (= pas tout le monde se met à marcher ou parler en même temps, mais on a des ordres d'idée).
Le plus grand point noir de ce point est surtout l'audition : les tests de dépistage sont relativement peu spécifiques et précis, donc souvent on fait directement des dépistages à la naissance. Si aucun dépistage n'a été fait et que les parents ont le moindre doute quant à un problème d'audition, un examen doit toujours être fait, dans le but de limiter le plus possible l'impact sur le futur langage de l'enfant.
- 7) Autres problèmes
 - Problèmes (chirurgicaux) courants
 - Situation psychosociale
 - État de santé de la mère
- 8) Planifier la prise en charge, communiquer et remplir le carnet de santé
 - Cette dernière étape revient à faire de la prévention auprès de la famille. Par exemple, pour la prévention primaire, il faut aborder le sujet des parents (tout avaler/respirer !), la position pour dormir (dormir sur le ventre = haut risque de mort subite !), etc. Pour la prévention secondaire, il faut plutôt s'interroger sur ce qui, dans l'environnement, provoque cette maladie (comme l'asthme) chez l'enfant et que faire pour l'éviter dans le futur. Pour la prévention tertiaire, on peut mettre en place des écoles thérapeutiques, indiquant aux parents et enfants comment se comporter face aux problèmes de santé (réduit très significativement leur consommation de soins). Finalement, quant à la prévention quaternaire, elle fait appel au bon sens, c'est-à-dire d'éviter les sur-diagnostic et les soins qui ne servent à rien.